



Réémergence épidémique de la rougeole en Europe : Évaluation de la couverture vaccinale et dynamique de transmission (2024-2026)



S.ABBACHE, C.KADRI, R.BOUROUCHE, H.ZERROUKI, F.ACILA, F.BELLOUT, S.GUENFOUD, M.ZITI

INTRODUCTION

La rougeole, une maladie virale hautement contagieuse causée par un morbillivirus, est une maladie évitable par la vaccination. Bien que la Région européenne de l'OMS se soit engagée à l'éliminer, la dynamique de transmission s'est considérablement modifiée à la suite de la pandémie de COVID-19.

Après des années de déclin historique, l'Europe fait face à un phénomène alarmant de réémergence épidémique entre 2024 et 2026, remettant en question l'immunité collective.

OBJECTIVES

Analyser quantitativement la recrudescence des cas de rougeole en Europe sur la période 2024-2026, identifier les populations les plus vulnérables et évaluer les défaillances de la couverture vaccinale.

METHODES

Une analyse épidémiologique descriptive et observationnelle rétrospective et prospective a été réalisée sur des données officielles issues du Système d'information sur la vaccination de l'**Organisation mondiale de la santé** (OMS) Europe, des rapports conjoints **UNICEF**, et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (**ECDC**).

Période d'étude : Janvier 2024 à Juin 2026.

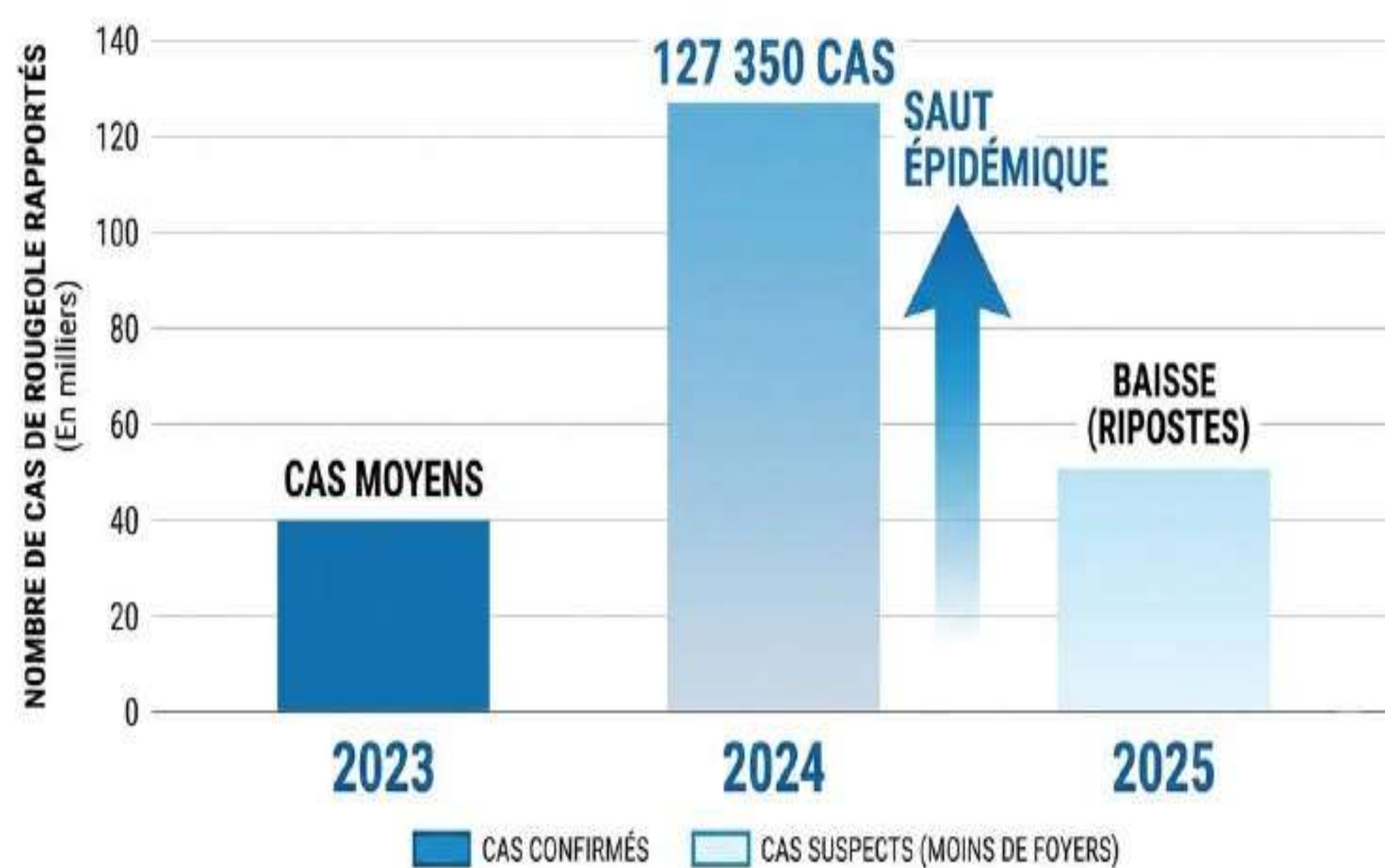
Indicateurs analysés : Incidence brute (nombre de cas cumulés), taux de couverture vaccinale pour la première dose (MCV1) et la deuxième dose (MCV2), taux d'hospitalisation, répartition par âge et statut vaccinal.

RESULTATS

A.L'explosion épidémique en chiffres

Le pic de 2024 : Un record absolu depuis 1997 a été enregistré dans la région Europe de l'OMS avec 127 350 cas, soit le double de l'année 2023. Cela représentait un tiers des cas mondiaux.

CRISES DE ROUGEOLE EN EUROPE: ANALYSE DE LA RÉÉMERGENCE
PÉRIODE D'ÉTUDE: 2023-2025



L'évolution en 2025-2026 : Bien que les données globales de 2025 montrent une baisse globale à 33 998 cas grâce aux campagnes de riposte, des foyers importants persistent.

En 2026, des résurgences saisonnières (hiver/printemps) maintiennent le virus actif, notamment avec des hausses de cas importés en Europe de l'Ouest (Espagne, France, Italie).

Mortalité et sévérité : En 2024, au moins 38 décès attribués à la rougeole en Europe.

Plus de la moitié (50 %) des patients infectés ont nécessité une hospitalisation.

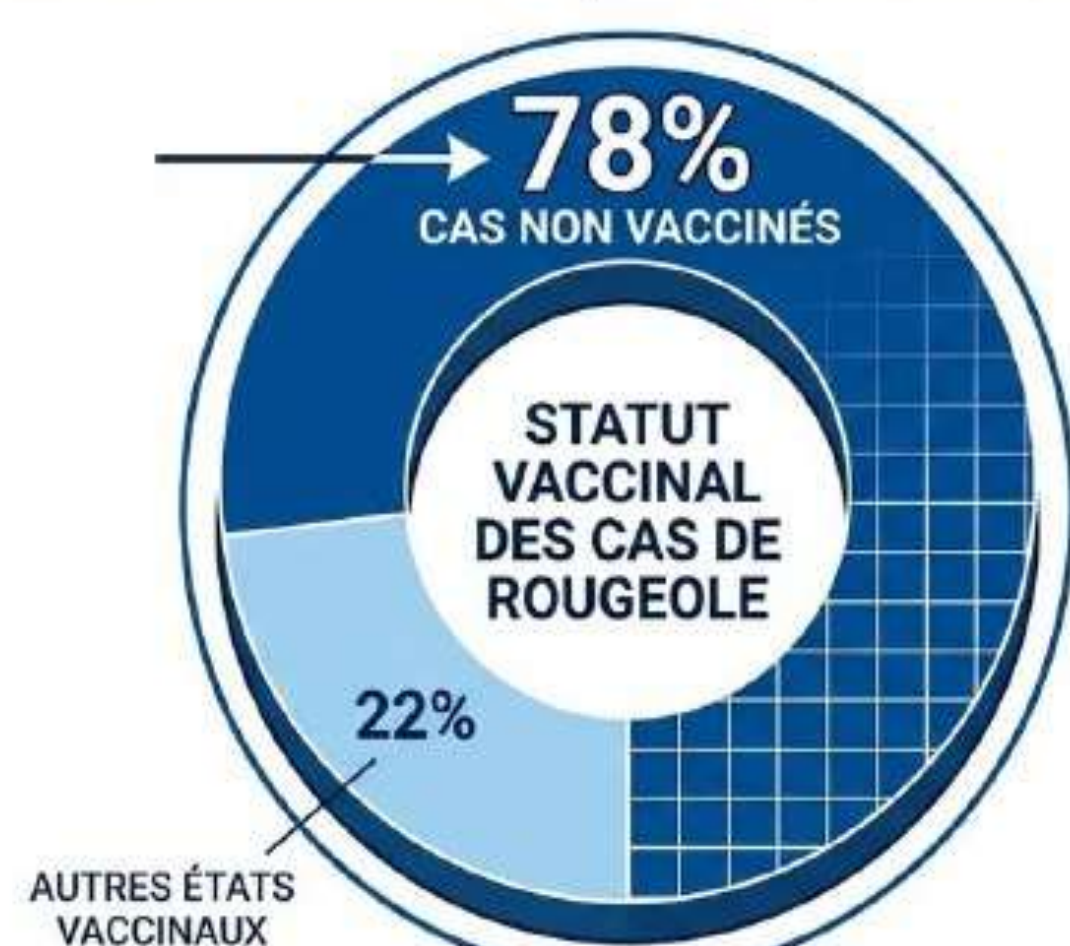
B. Profils démographiques et statut vaccinal (Données ECDC)

Âge : Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés (plus de 40 % des cas en 2024). Une seconde cohorte vulnérable émerge chez les jeunes adultes (15 ans et plus), représentant près de 44 %.

Statut vaccinal : L'analyse des cas montre que 78,1 % des personnes infectées n'étaient pas vaccinées. 12,1 % n'avaient reçu qu'une seule dose.

ANALYSE DE LA COUVERTURE VACCINALE (2024-2026)

Données basées sur les épidémies récentes en Europe



Données synthétiques issues de rapports de l'OMS et de l'ECDC (période d'étude 2024-2026)

RÉÉMERGENCE DE LA ROUGEOLE EN EUROPE : TABLEAU ÉPIDÉMIOLOGIQUE (2024-2025)

Indicateur Épidémiologique (Europe)	Année 2024	Année 2025
 Nombre total de cas rapportés	127 350	33 998
 Principaux foyers (exemples)	Roumanie (~30k), Kazakhstan (~28k)	Espagne, Royaume-Uni (foyers persistants)
 Statut vaccinal des cas infectés (%)	78,1 % Non vaccinés / 12,1 % Une seule dose	Données non spécifiées (or en cours de validation)

*Données basées sur une synthèse de rapports issus de l'OMS, de l'UNICEF et de l'ECDC (Période d'étude 2024-2026). *

DISCUSSION

Interprétation des causes :

La cause majeure de cette réémergence est le **"backsliding" (le recul) vaccinal** amorcé pendant la pandémie de COVID-19.

En Europe, la couverture de la première dose (MCV1) a stagné autour de 84-85 % en 2024, alors que le seuil d'immunité collective requis pour bloquer ce virus est **de 95 % avec deux doses**.

Facteurs aggravants :

La prolifération de la désinformation et de l'hésitation vaccinale post-crise sanitaire. Des poches d'immunovulnérabilité critiques (ex: certaines régions des Balkans affichaient des taux MCV1 inférieurs à 50-70 %).

Implications de santé publique :

La rougeole n'est plus une maladie de l'enfance en voie d'éradication en Europe, mais une menace immédiate pour la sécurité sanitaire régionale.

CONCLUSION

Le virus de la rougeole agit comme un "révélateur" des failles des systèmes de santé. Pour stopper le retour des virus oubliés d'ici la fin 2026, les politiques publiques doivent impérativement mener des campagnes de rattrapage vaccinal ciblant les enfants ayant manqué leurs doses entre 2020 et 2024, et restaurer la confiance envers les vaccins de routine.

REFERENCES

- Organisation mondiale de la Santé (OMS) & UNICEF.** European Region reports highest number of measles cases in more than 25 years. Communiqué de presse conjoint OMS/UNICEF, Genève/Copenhague, 13 mars 2025.
- Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).** Measles - Annual Epidemiological Report for 2024. Stockholm : ECDC ; 2025.
- OMS Bureau régional de l'Europe.** EpiBrief No. 1/2025: Measles and rubella surveillance data in the WHO European Region. Copenhague : OMS Europe ; 2025.
- Guerra FM, Bolotin S, Lim G, et al.** The basic reproduction number (R₀) of measles: A systematic review. The Lancet Infectious Diseases, 2017; 17(12): e420-e428.